

放射性摄取比(R) = 病灶侧 ROI 放射性计数 / 对侧对称区域(镜像区)ROI 放射性计数。

1.4 统计学方法 采用 SPSS18.0 软件对数据进行处理,计量资料以均数 $\pm$ 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示,采用 t 检验;计数资料采用 χ^2 检验。以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

表1 两组治疗2周后两组NIHSS评分、mRS指数比较($\bar{x} \pm s$)

分组	例数	NIHSS 评分		mRS 指数	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
治疗组	30	11.32 $\pm$ 2.07	6.24 $\pm$ 2.19 ^{ab}	3.15 $\pm$ 0.49	1.59 $\pm$ 0.56 ^{ab}
对照组	30	11.24 $\pm$ 2.45	7.63 $\pm$ 1.91 ^a	3.24 $\pm$ 0.54	2.45 $\pm$ 0.47 ^a

注:与治疗前比较,^a $P < 0.05$;治疗后与对照组比较,^b $P < 0.05$

表2 两组治疗2周后rCBF变化($\bar{x} \pm s$, R)

分组	例数	治疗前	治疗后
治疗组	30	0.45 $\pm$ 0.21	0.69 $\pm$ 0.29 ^a
对照组	30	0.47 $\pm$ 0.19	0.54 $\pm$ 0.23

注:与对照组比较,^a $P < 0.05$

表3 两组中大面积脑梗死患者治疗2周后rCBF变化(R)、mRS指数比较($\bar{x} \pm s$)

分组	例数	rCBF(R)		mRS 指数	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
治疗组	14	0.38 $\pm$ 0.32	0.42 $\pm$ 0.19 ^a	4.25 $\pm$ 0.37	2.47 $\pm$ 0.49 ^a
对照组	13	0.39 $\pm$ 0.34	0.43 $\pm$ 0.23	4.31 $\pm$ 0.45	3.59 $\pm$ 0.64

注:与对照组比较,^a $P < 0.05$

3 讨论

脑血管病严重危害着我国人民的健康,每年有200万以上的新增脑血管病患者,约150万人死于脑卒中,其中60%~80%为缺血性脑卒中,给家庭、社会带来了巨大的精神、物质负担^[2]。目前认为急性脑梗死病灶由中心坏死区及周围缺血半暗带组成,坏死区域由于完全性缺血导致脑细胞不可逆死亡,而缺血半暗带仍存在侧支循环,可获得部分血液供应,尚有大量存活神经元,如该部分血流迅速恢复,损伤可逆^[3,4]。

结果显示,治疗组治疗2周后NIHSS评分明显低于治疗前,且优于对照组($P < 0.05$);随访3个月,mRS指数明显优于对照组($P < 0.05$),提示尤瑞克林可以提高脑梗死的治疗效果,提高患者的日常生活能力,使患者早日回归家庭和社会,同时治疗组治疗前后ROI比值比较差异有统计学意义($P < 0.05$),尤瑞克林可以改善脑梗死局部血流量变化,同徐恩等人的研究相仿。大面积脑梗死病例治疗前后ROI比值变化不明显考虑本次研究采用SPECT半定量研究,放射性计数比值变化不如绝对值明显,但患者mRS评分较对照组差异显著,

治疗组rCBF、NIHSS评分、mRS指数明显优于对照组($P < 0.05$),均无明显不良反应。两组患者中大面积脑梗死患者rCBF变化不明显,但mRS指数评分明显优于对照组($P < 0.05$)。所有病例未出现严重低血压,1例患者静脉滴注尤瑞克林中出现面部发红,调整滴速后好转,未停止用药。实验组所有病例无明显肝肾功能损害,无凝血时间异常。见表1、2、3。

说明尤瑞克林可以促进大面积脑梗死患者远期神经功能的恢复,提高远期生活质量。治疗过程中,有1例患者出现面色潮红,调整滴数后缓解,未停药。无一例患者出现明显血压下降。治疗前后监测血常规、肝肾功能、凝血时间均在正常范围。可见,尤瑞克林较为安全。

参 考 文 献

- [1] 王维治,罗祖明.神经病学.第5版.北京:人民卫生出版社,2006:134-140.
- [2] 周莉华,孙晓江.SPECT在常见脑血管疾病中的应用研究.中国临床神经科学杂志,2005,13(3):333-336.
- [3] 潘燕,张保朝.尤瑞克林对急性脑梗死炎症反应物及血管内皮的影响.中华脑血管病杂志(电子版),2010,4(4):172-176.
- [4] 石秦东,张军峰,张蓬勃,等.尤瑞克林对大鼠局灶性脑缺血半暗带脑血流量影响的研究.中国神经精神疾病杂志,2008(34):413-416.

[收稿日期:2014-05-05]

辛伐他汀的不良反应及药物相互作用分析

李敏

【摘要】 目的 评价辛伐他汀药物不良反应以及其与其他药物相互作用的临床效果。方法 总结本院内科门诊开出含有辛伐他汀的处方并加以分析。结果 所有200例不良反应病例中,神经系统、肾脏系统及皮肤系统是较常见发生不良反应的系统,大环内酯类药物与辛伐他汀共用时易发生不良反应。结论 辛伐他汀使用不当易发生不良反应,应注意根据用药人群进行剂量、配伍药物的选择,以减少发生辛伐他汀的不良反应。

【关键词】 辛伐他汀;回顾性分析;不良反应

作者单位:472500 河南省灵宝市第一人民医院药剂科

辛伐他汀是临床上较常用的降脂药之一,其降血脂效果较好,但存在很多不良反应,并且在与代谢酶抑制剂类药物合用时也会发生不良反应。作者对本院 2013 年 1~12 月开出含有辛伐他汀处方而发生不良反应的病例进行回顾性分析,试为临床使用辛伐他汀时预防药物不良反应有所提示^[1]。

1 样本与方法

1.1 研究对象 将本院内科门诊 2013 年 1~12 月含有辛伐他汀的处方不良反应 200 例进行总结。其中男 108 例,年龄 44~73 岁,平均年龄 (56.5±2.3) 岁;女 92 例,年龄 43~75 岁,平均年龄 (61.2±3.1) 岁。

1.2 研究方法 作者通过使用电子病例管理检索系统,检索出门诊中含有辛伐他汀处方的电子病例,筛选其中发生不良反应事件的病例,将与辛伐他汀合用而发生相互作用的处方进行记录,分析不良反应产生的原因并进行归类。

1.3 统计学方法 记录电子病例中发生辛伐他汀不良反应的情况,数据资料均建立 Excel 2013 数据库,并采取 SPSS19.0 的统计学软件进行数据分析,计量资料以均数 ± 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 形式表示,实施 t 检验;计数资料以率 (%) 形式表示,实施 χ^2 检验, $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

辛伐他汀不良反应累及很多系统,具体统计结果见表 1。

表 1 200 例辛伐他汀发生不良反应系统的病例数统计 (n, %)

发生不良反应系统	例数	不良反应比例
神经肌肉系统	69	34.5
肝肾系统	42	21
皮肤系统	31	15.5
神经系统	23	11.5
血液系统	20	10
胃肠道系统	15	7.5

此外,统计联合用药发生辛伐他汀不良反应的药物有,红霉素类药物 32 例,烟酸 23 例,阿托伐他汀 13 例,地高辛 3 例。

3 讨论

辛伐他汀常见不良反应中,最常见也是最集中的是神经肌肉系统异常。其主要表现有肌酸磷酸激酶升高、肌肉痛、关节痛、肌肉无力等^[2]。作者认为,虽然服用辛伐他汀后发

生磷酸肌酸激酶升高的病例较多,但是其升高与服药后出现短暂升高有关,如发生磷酸肌酸激酶升高超过正常值 10 倍时可认为发生了显著性升高,可以考虑为神经肌肉系统发生异常^[3]。本次病例回顾分析中,有 42 例发生肝肾系统异常的辛伐他汀不良反应,因此对于服用辛伐他汀后出现蛋白质损失的病例可提示患者发生服药后肾脏损伤的不良反应。对于皮肤系统而言,本次回顾的 200 例不良反应病例中有 31 例发生该系统损伤,其中主要是脱发、皮疹等不良反应。通过结果统计可以看出,辛伐他汀不良反应也可发生在血液系统、胃肠道系统、神经系统等,虽然其发生的比例不高,但是依然会对患者产生较大危险,临床用药中应尤为注意。

辛伐他汀与其他药物合用也会产生不良反应。通过本次回顾分析,总结出如下合用发生不良反应的情况:①辛伐他汀与大环内酯类药物合用可能发生不良反应,主要表现为肌酸激酶升高、肝肾系统损伤等^[4]。②辛伐他汀与其他调脂类药物联合使用也有不良反应发生的病例。本次回顾中阿托伐他汀与辛伐他汀合用造成患者发生不良反应有 13 例。分析原因可能是辛伐他汀是酯化的前体药物,服用后进入体内反应成为辛伐他汀酸,此时如与其他药物进行合用会导致辛伐他汀有效成分改变^[5]。

综上所述,在使用辛伐他汀时,应注意根据用药人群进行剂量、配伍药物的选择,以减少发生辛伐他汀的不良反应。

参 考 文 献

- [1] 钟秋红. 辛伐他汀的不良反应及与其他药物的相互作用. 中国现代药物应用, 2013, 7(19):144-145.
- [2] 李平, 王敏, 陈岚. 辛伐他汀致横纹肌溶解不良反应 1 例. 中国药物警戒, 2013, 10(8):512.
- [3] 李勇, 陈富荣, 黄景文. 辛伐他汀联合非诺贝特治疗混合性高脂血症的疗效观察. 中国医药科学, 2012, 2(2):17-19.
- [4] 王利平. 辛伐他汀的不良反应和防治 (附 35 例报告). 中国实用医药, 2010, 5(22):16-17.

[收稿日期: 2014-05-04]

中西医结合红光治疗外阴硬化性苔藓的临床观察

康文

【摘要】 目的 探讨分析中西医结合红光治疗外阴硬化性苔藓的临床效果。方法 选择本院收治的外阴硬化性苔藓患者 84 例,随机分为观察组和对照组,各 42 例,对照组采用西医结合红光治疗,观察组在与对照组相同治疗的基础上联合中药治疗,比较两组的治疗效果及复发率。结果 观察组治疗总有效率 97.62%,高于对照组 80.95%,差异有统计学意义 ($P < 0.05$);对两组治疗有效的患者随访 6 个月,观察组复发率 2.44%,低于对照组 23.53%,差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论 中西医结合红光治疗外阴硬化性苔藓,疗效显著,复发率低,值得临床推广。

【关键词】 中西医结合;红光;外阴硬化性苔藓;治疗效果

外阴硬化性苔藓 (lichen sclerosus of vulva, VLS), 是以外阴、肛周皮肤变薄萎缩为主的一种皮肤病,多见于女性,特

别是 40 岁左右的女性^[1],主要出现外阴皮肤及黏膜不同程度变白、奇痒,甚至外阴皮肤粗糙、肥厚、粘连、破溃、阴道狭窄等临床症状,给患者的生活造成严重影响。目前,该病发病原因尚不清楚,治疗方法也较有限,作者通过对本院

作者单位: 516400 广东省汕尾市海丰中医院妇产科